HELP_Organi_P18 — Groupe D — Lots 237 à 241 — 20 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 18 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

D-046 — Moyenne — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › A › Bloc 1 › point 2 (fréquences) ; P1 › DX.1 et DX.2 › point 2 ; P2 › DX.3–DX.5 › point 2 ; P3 › DX.6 fenêtres « 15 000 expertises » et « nouvelles rentes », DX.7 fenêtre « 350 000 personnes de 70 ans et plus »

Contexte : Le cours écrit : fréquence des demandes rétroactives, de complaisance, des employeurs, des autorités, des incapacités partielles et des rapports aux assureurs non trouvée ; rapport SuisseMED@P 2024 introuvable ; chiffres OFS actuels des conducteurs âgés et comparaisons européennes non trouvés.

Question : Quelles données suisses récentes (OFS, OFAS, SuisseMED@P rapport annuel 2024/2025, OFROU, Obsan, études SIM/FMH) chiffrent : les certificats d'incapacité de travail, les expertises AI (mono-, bi-, pluridisciplinaires), les nouvelles rentes AI pour motif psychique, les conducteurs de 70/75 ans et plus et les examens d'aptitude ? À défaut, quelles données européennes comparables ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-047 — Moyenne — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.8 › fenêtre « mort subite du nourrisson », point 6 (mort apparente), drapeaux rouges, point 2 (décès extraordinaires)

Contexte : Le cours cite l'ASSM 2017/2021 : 6 à 8 morts subites du nourrisson par an ; liste suisse des signes sûrs de la mort, liste exhaustive des signes de mort non naturelle, diagnostic différentiel de la mort apparente et nombre de décès extraordinaires (OFS) non trouvés.

Question : Combien de décès extraordinaires (et de morts subites du nourrisson) l'OFS ou les instituts de médecine légale suisses ont-ils recensés la dernière année disponible ? Quelle liste suisse (ASSM, SSML, législation cantonale) définit les signes sûrs de la mort et les indices de mort non naturelle ? Quelles causes de mort apparente (hypothermie, intoxication) imposent la réanimation ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-048 — Moyenne — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.8 › point 9 › estimation de l'intervalle post-mortem (nomogramme de Henssge)

Contexte : Le cours tire les formules et tolérances (± 2,8 h, ± 3,2 h, ± 4,5 h) de Zirn 2026 ; Henssge et Madea 2004 (texte original) non lu.

Question : Le texte original de Henssge (nomogramme, 1988) ou de Henssge et Madea 2004 donne-t-il les mêmes tolérances (± 2,8 h, ± 3,2 h, ± 4,5 h) et les mêmes facteurs correctifs ? Citer la référence exacte.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-049 — Moyenne — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc DX.3 › point 9 › évaluation de la capacité fonctionnelle (termes CIF)

Contexte : Le cours utilise des traductions CIF faites par l'auditeur (version française officielle non lue).

Question : Quels termes officiels la traduction française de la CIF (OMS) donne-t-elle pour : mobilité, motricité fine, fonctions sensorimotrices, cognition, fonctions psychiques (avec codes b/d) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :

5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-050 — Moyenne — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › A › exemples d'aptitude (hémianopsie, glaucome, lombosciatique) sans fenêtre propre

Contexte : L'audit signale que les termes sémiologiques des exemples n'ont aucune définition sourcée.

Question : Où trouver une définition sourcée, suisse ou européenne (CIM-11 OMS, EGS, OAC annexe 1), de l'hémianopsie, du glaucome et de la lombosciatique, et quelles exigences visuelles minimales (champ visuel) fixe l'OAC annexe 1 pour les groupes 1 et 2 ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-051 — Moyenne — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc DX.1 › fenêtre « fièvre » ; LOT_240 P1 › DX.1 › fenêtre « fièvre » et tableau « Température » ; LOT_240 P4 › DX.9 › fenêtre « Fièvre »

Contexte : Le cours écrit : seuil chiffré de la fièvre et seuil thermique du critère de Centor non trouvés.

Question : Quel seuil de température (°C, site de mesure) définit la fièvre selon une source suisse ou européenne (SSI, pédiatrie suisse, ESCMID) ? Quel seuil retient le score de Centor/McIsaac (> 38 °C) dans la recommandation suisse sur la pharyngite ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-052 — Moyenne — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.9 › fenêtre « Levée du secret » (P1 DX.2) ; fenêtre transversale « Sanctions » (CP 320) ; DX.10 › fenêtres « grossesse » (LTr 35a) et « LTr art. 36 et CO art. 329h »

Contexte : Le cours écrit : forme de la demande de levée du secret selon le canton, texte de CP 320 non relu, document médical exigé pour établir la grossesse et articulation LTr 36 al. 4 / CO 329h non trouvés.

Question : Quel est le texte en vigueur de CP art. 320 et 321 (peines) ? Comment s'articulent LTr art. 36 al. 3–4 et CO art. 329h (congé pour proche, enfant malade) selon le SECO ? Quel document médical l'employeur peut-il exiger pour la grossesse (OLT 1, ordonnance sur la protection de la maternité) ? Quelle procédure de levée du secret professionnel prévoit le canton de Neuchâtel (autorité, formulaire) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-053 — Moyenne — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc DX.3 › point 11 › chômeur apte au placement (brochure SIM)

Contexte : L'audit signale la règle « chômeur apte au placement ≥ 50 % » tirée de la brochure SIM 2022 abrogée ; la reprise dans la brochure SIM 2026 n'est pas vérifiée.

Question : La brochure SIM 2026 (Swiss Insurance Medicine) sur l'évaluation de l'incapacité de travail reprend-elle la règle de l'aptitude au placement (≥ 50 %) pour le chômeur ? Quel texte (LACI art. 15, OACI) la fonde ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-054 — Haute — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.9 › point 11.B › « Fiche ③ : pivmécillinam » (mécanisme, contre-indications), fiche fosfomycine, fenêtre AINS, tableau des alternatives

Contexte : Le cours écrit : mécanisme et contre-indications du pivmécillinam non trouvés ; statut Swissmedic non vérifié ; spécialités suisses des alternatives non vérifiées ; adaptation hépatique de la fosfomycine et posologie de l'AINS dans la cystite non trouvées.

Question : Une information professionnelle suisse existe-t-elle pour le pivmécillinam (Selexid®) ? Si oui, quelles posologie, durée et contre-indications pour la cystite simple ? Sinon, quelles alternatives la recommandation SSI la plus récente (infections urinaires) retient-elle, avec spécialités suisses, doses (fosfomycine, nitrofurantoïne, triméthoprime) et adaptations ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-055 — Haute — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc DX.3 › points 2, 7, 9 (PSA, IRM multiparamétrique, biopsie, toucher rectal) et 11.C (intervalle de répétition) ; A › tableau PSA

Contexte : Le cours s'appuie sur PCPT et sur le résumé de l'EAU 2024 (texte intégral : erreur 404) ; seuils de PSA, intervalles, valeur de référence, échelle de score IRM et sensibilité/spécificité de l'IRM et de la biopsie non trouvés ; SSMIG : limite 75 ans.

Question : Quels seuils de PSA (selon l'âge), quels intervalles de répétition et quelle place de l'IRM (PI-RADS ≥ 3) et des calculateurs de risque la guideline EAU 2025 (ou 2026) retient-elle pour le dépistage individuel et la décision de biopsie ? Quelles sensibilité et spécificité de l'IRM multiparamétrique ? Quelle position de la SSMIG / Smarter Medicine et de la Société suisse d'urologie ? Citer la recommandation suisse en vigueur (titre, année, URL) ; comparer la version la plus récente à celle du cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-056 — Haute — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc DX.1 › point 9 (otoscopie) et point 11.B › tableau « 3e intention (OMA sans amélioration) » (amoxicilline)

Contexte : Le cours donne la posologie FI d'Amoxicilline Spirig HC® ; l'agent, la durée et l'abstention fixés par une recommandation pédiatrique suisse (PIGS/SSI) n'ont pas été lus (guidelines.ch dynamique) ; critères otoscopiques non trouvés.

Question : Quelle recommandation suisse (Pédiatrie suisse / PIGS / SSI) encadre l'otite moyenne aiguë : critères otoscopiques, âge et critères de l'abstention, dose d'amoxicilline (mg/kg/j, nombre de prises), durée selon l'âge, alternative en cas d'allergie ? Donner titre, année, URL ; comparer à la version citée. Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-057 — Haute — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc DX.1 › point 9 › tableau « TAR streptococcique » et fenêtre « allergie croisée », fenêtre « Pénicilline V » (alternative)

Contexte : Le cours cite la recommandation suisse [S66, S10] : TAR seulement si Centor 3–4 ; performance du TAR et alternative sûre en cas d'allergie aux pénicillines non trouvées.

Question : Quelles sensibilité et spécificité du test antigénique rapide streptococcique cite la recommandation SSI la plus récente (pharyngite) ? Quelle alternative antibiotique (molécule, dose, durée) recommande-t-elle en cas d'allergie aux pénicillines (immédiate ou non) ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :

5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-067 — Haute — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.9 › points 2, 9 (culture, bandelette) et 9.c (grossesse, enfant)

Contexte : Le cours signale une divergence : l'EAU impose une culture pendant la grossesse alors que la SSGO déconseille le dépistage [S85, S11] ; conduites pédiatriques, Se/Sp de la bandelette et de la culture, prévalence suisse non trouvées.

Question : Que recommandent aujourd'hui la SSGO (avis d'experts le plus récent) et l'EAU 2025 sur le dépistage et le traitement de la bactériurie asymptomatique pendant la grossesse ? Quelle conduite chez l'enfant (Pédiatrie suisse/PIGS) ? Quelles sensibilité et spécificité de la bandelette urinaire (leucocytes, nitrites) ? Présenter la divergence et la source la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-068 — Haute — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.10 › point 2, fenêtres « autres items du score de Genève », « diagnostics alternatifs », tableau « scintigraphie V/Q », point 9.c (enfant, grossesse)

Contexte : Le cours cite l'ESC 2019 (texte original inaccessible, classes de seconde main), YEARS et ADJUST-PE ; définition du « cancer actif », Se/Sp de la scintigraphie, conduite pédiatrique et fréquence suisse non trouvées.

Question : Une guideline ESC sur l'embolie pulmonaire plus récente que 2019 est-elle publiée ? Quelles classes et niveaux pour : D-dimères ajustés à l'âge, YEARS, stratégie pendant la grossesse (algorithme), scintigraphie V/Q ? Quelle définition du cancer actif et quelle conduite chez l'enfant ? Citer la recommandation suisse en vigueur (titre, année, URL) ; comparer la version la plus récente à celle du cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-058 — Moyenne — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › A › fenêtre « Interprétation » (CT cérébral) ; P1 › DX.1 tableau « Imagerie de la rhinosinusite » et DX.2 fenêtres « radiographie, CT, IRM » et « Dose d'irradiation » ; P3 › DX.7 (grossesse) ; P4 › DX.8 tableau « CT du crâne »

Contexte : Le cours donne les niveaux de référence diagnostiques OFSP (CTDIvol, DLP) et 0,1 mSv pour la radiographie thoracique ; doses efficaces en mSv du CT des sinus, de l'imagerie lombaire et du CT cérébral non trouvées ; choix de la modalité chez la femme enceinte et l'enfant non trouvé.

Question : Quelles doses efficaces typiques (mSv) l'OFSP, l'EURATOM (Radiation Protection 180) ou la Commission européenne publient-elles pour : radiographie du thorax, radiographie lombaire, CT lombaire, CT thoracique, CT cérébral, CT des sinus, angio-CT thoracique ? Quelle conduite d'imagerie chez la femme enceinte et l'enfant recommande l'OFSP ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-059 — Moyenne — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › A › fenêtre « pacemaker et IRM » ; P1 › DX.2 fenêtre « Allergie aux produits de contraste iodés et pacemaker » ; P4 › DX.8 fenêtre « IRM et pacemaker »

Contexte : Le cours cite l'ESC 2021 (stimulation cardiaque) via une source secondaire : IRM possible si système « MR-conditional » ; classe et conditions pour un système non compatible non lues.

Question : Que recommande l'ESC 2021 (stimulation cardiaque et resynchronisation) pour l'IRM chez un porteur de stimulateur non compatible IRM (classe, niveau, conditions : délai depuis l'implantation, mode de stimulation, surveillance) ? Une position suisse (Société suisse de cardiologie, Swissmedic) existe-t-elle ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-060 — Moyenne — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › A › tableau « Interprétation » (CRP) ; P1 › tableau « CRP et FSC » ; P4 › DX.9 fenêtres « CRP », « PCT » et tableau « CRP et PCT »

Contexte : Le cours écrit : valeurs de référence suisses de la CRP et de la PCT non trouvées (fiche CHUV sans intervalle) ; « aucun seuil ne justifie à lui seul un antibiotique » [S4].

Question : Quelles valeurs de référence de la CRP et de la PCT publient les laboratoires universitaires suisses ou la SSMIG ? Quels seuils de PCT pour initier ou arrêter un antibiotique (infections respiratoires basses, sepsis) recommandent l'ESCMID ou la SSI ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-061 — Moyenne — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc DX.2 › point 11.B › tableau « 2e (opioïdes faibles) » ; fenêtres « traumatisme significatif », « spondylarthrite », « STarT Back » ; tableau des manœuvres ; point 11.C (fonction rénale sous AINS)

Contexte : Le cours s'appuie sur NICE (Royaume-Uni) et sur des méta-analyses ; agent et dose de l'opioïde faible, critères de la spondylarthrite, seuils STarT Back, définition du traumatisme significatif, Se/Sp des manœuvres et calendrier de surveillance rénale sous AINS non trouvés.

Question : Quelle recommandation suisse (SSMIG, Smarter Medicine, Société suisse de rhumatologie) ou européenne la plus récente encadre la lombalgie aiguë non spécifique : drapeaux rouges définis, outil STarT Back (seuils), place et dose des opioïdes faibles (tramadol, codéine), surveillance rénale sous AINS ? Quels critères ASAS de la lombalgie inflammatoire ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-062 — Moyenne — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc DX.4 › point 9 › tableaux « magnésémie », « chromogranine A », « vitamine B12 », « endoscopie » ; fenêtre NNH ; point 11.B (schéma de déprescription)

Contexte : Le cours tire les schémas de déprescription des IPP de sources canadiennes (Bruyère/CFP) ; valeurs de référence (Mg, B12, chromogranine A) et nécessité d'une endoscopie avant sevrage non trouvées.

Question : Quel schéma de déprescription des IPP (réduction de dose, prise à la demande, arrêt) recommande une source suisse (Smarter Medicine, SSG/SGG) ou européenne (UEG, ESPGHAN) ? Une endoscopie est-elle exigée avant l'arrêt en l'absence de symptôme d'alarme ? Quelle surveillance de la magnésémie et de la vitamine B12 sous IPP prolongé (FI suisse) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-063 — Moyenne — LOT 240 · SSP O7.18

Emplacement : LOT_240_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc DX.5 › fenêtre « insomnie », points 4, 8, 9 (agenda, questionnaires, actigraphie, polysomnographie) et 9.c (zolpidem si DFGe < 30)

Contexte : Le cours cite la guideline européenne sur l'insomnie [S58] : critères chiffrés (fréquence, durée), seuils des questionnaires, instrument d'évaluation de la marche/cognition et adaptation du zolpidem si DFGe < 30 non trouvés ; déprescription BZRA de source canadienne.

Question : Quels critères diagnostiques chiffrés de l'insomnie chronique (nuits par semaine, durée) donnent la CIM-11 et la guideline européenne ESRS 2023 ? Quels seuils de l'Insomnia Severity Index ? Que dit la FI suisse du zolpidem en insuffisance rénale sévère ? Quel schéma de sevrage des BZRA chez la personne âgée recommande une source suisse ou européenne ? Citer la

recommandation suisse en vigueur (titre, année, URL) ; comparer la version la plus récente à celle du cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P18 — 20 questions : D-046, D-047, D-048, D-049, D-050, D-051, D-052, D-053, D-054, D-055, D-056, D-057, D-067, D-068, D-058, D-059, D-060, D-061, D-062, D-063